



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS VOKASI

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. (031) 5033869 Fax (031) 5053156
Laman : <https://vokasi.unair.ac.id>, e-mail : info@vokasi.unair.ac.id

Nomor : 1112/B/DST/UN3.FV/PK.01.06/2026
Lamp : 1 Lembar
Hal : Permohonan Izin PKL

29 Januari 2026

Yth. Direktur
RS Prima Husada
Jl. Raya Mondoroko, Mondoroko, Banjararum, Kec. Singosari
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan kurikulum berupa PKL yang dilaksanakan oleh mahasiswa, maka kami mohon kesediaan Bapak/Tbu untuk mengizinkan mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan untuk melaksanakan PKL di RS Prima Husada. Adapun Waktu pelaksanaan PKL tersebut direncanakan pada 22 Juni-22 Juli 2026 dan nama mahasiswa terlampir.

Mohon konfirmasi surat balasan PKL Mahasiswa ke alamat Email Prodi : radiologi@vokasi.unair.ac.id, atau dapat menghubungi narahubung dosen penanggung jawab PKL Mahasiswa Semester 4 a.n Bp. Ayub Manggala Putra, S.Tr.Kes., M.Sc (0812-3991-0618)

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Dekan,

Prof. Dian Yulie Reindrawati, S.Sos., M.M., Ph.D
NIP.197607071999032001

Tembusan:

1. Ketua Departemen Kesehatan
2. Koordinator Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Lampiran Surat No : 1112/B/DST/UN3.FV/PK.01.06/2026

Tanggal : 29 Januari 2026

**DAFTAR MAHASISWA DAN PEMBIMBING
PRAKTIK KERJA LAPANGAN/MAGANG RS
SEMESTER GENAP 2025/2026**

PKL SEMESTER 4 RS Prima Husada PERIODE PKL : 22 JUNI – 22 JULI 2026				
NO	NIM	NAMA	DOSEN PEMBIMBING	INSTRUKTUR KLINIS / CLINICAL INSTRUCTOR
1	413241006	FATIKHA BELLA FAHRENZI	Berliana Devianti Putri, S.KM., M.Kes	Instruktur Klinis RS Prima Husada
2	413241046	SRI KANDI DEWI AYU MAWARDANI		
3	413241049	DESTI RIZKI SOLEHA		
4	413241051	ABBAAD AL KHALIL		
5	413241093	NOVIA RAHMAWATI		
6	413241102	EKTIN PUTRI RAHMAWATI		

NARAHUBUNG PJ PKL SEMESTER 4 : 081 239 910 618 (AYUB)

PROPOSAL
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
RADIOGRAFI KLINIK I
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN (D-IV)
TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI
SURABAYA
2026

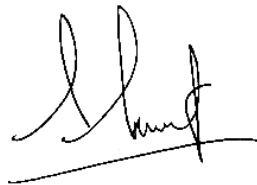
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) RADIOGRAFI KLINIK I
PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Proposal kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Radiografi Klinik 1 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PKL bagi mahasiswa semester 4 Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Proposal ini telah disetujui dan disahkan untuk dilaksanakan.

Surabaya, 01 Januari 2026

Koordinator Program Studi
D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga



Muhaimin, S.Tr.Kes., M.T

NIP. 199002252020073101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan (TRP) merupakan program studi vokasional yang menekankan pada penguasaan keterampilan terapan di bidang pencitraan radiologi. Kurikulum pendidikan vokasi berbeda dengan pendidikan akademik, di mana beban studi dalam program vokasi lebih dititikberatkan pada kegiatan praktikum dan praktik. Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), proporsi pembelajaran pada pendidikan vokasi adalah 40% teori dan 60% praktik, dengan masa studi yang dapat ditempuh selama 8 (delapan) semester atau empat tahun.

Kurikulum yang saat ini berjalan di Program Studi D-IV TRP Universitas Airlangga disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Dalam SN Dikti, capaian pembelajaran (CP) lulusan harus mencakup empat unsur, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Oleh karena itu, proses pembelajaran dirancang secara sistematis yang mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi perkuliahan.

Sistem pembelajaran di Universitas Airlangga menerapkan pendekatan *Student-Centered Learning* (SCL), yang dituangkan dalam berbagai metode pembelajaran aktif seperti Problem-Based Learning, Case-Based Learning, Research-Based Learning, Lifelong Learning, dan Forum Group Discussion (FGD). Pendekatan ini diharapkan mampu mengembangkan daya pikir kritis, pemecahan masalah, serta keterampilan kerja kolaboratif mahasiswa. Untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), evaluasi terhadap pembelajaran praktik dilakukan melalui penyusunan portofolio kegiatan praktikum dan praktik kerja mahasiswa. Evaluasi ini sekaligus menjadi upaya dalam memperkuat keterkaitan (*link and match*) antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), pembelajaran tidak hanya dibatasi di dalam ruang kelas maupun lingkungan kampus. Mahasiswa didorong untuk belajar langsung di lingkungan

kerja nyata melalui kegiatan seperti magang, studi independen, proyek desa, maupun praktik kerja lapangan (PKL). Program PKL menjadi salah satu bentuk nyata dari implementasi MBKM, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran vokasional di Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama proses pembelajaran, tetapi juga menjadi pengalaman penting untuk membentuk etika kerja, sikap profesional, serta kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja di bidang radiologi pencitraan.

1.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan beban SKS praktik dalam kurikulum Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan, yang menekankan proporsi pembelajaran praktik sebesar 60%. Adapun tujuan dari kegiatan PKL ini adalah:

1. Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang telah diperoleh selama proses perkuliahan dalam praktik nyata di lingkungan pelayanan radiologi.
2. Meningkatkan kompetensi teknis dan kesiapan kerja mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam prosedur pelayanan radiologi sesuai standar yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Mendukung implementasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) melalui pembelajaran berbasis pengalaman langsung di luar kampus, guna memperkuat keterkaitan antara kurikulum pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja.

1.3 Manfaat

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi institusi pendidikan dan mitra penyelenggara layanan kesehatan. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1.3.1 Mahasiswa

1. Memberikan pengalaman langsung dalam dunia kerja nyata sehingga dapat mengasah keterampilan teknis, komunikasi, dan etika profesi.
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap prosedur kerja, alur pelayanan, dan teknologi yang digunakan dalam instalasi radiologi.
3. Menjadi wadah untuk mengukur kesiapan diri dalam memasuki dunia kerja serta membangun jejaring profesional.

1.3.2 Institusi Pendidikan

1. Menjadi sarana evaluasi implementasi kurikulum vokasi melalui umpan balik dari dunia kerja (rumah sakit atau institusi mitra).
2. Meningkatkan hubungan kemitraan strategis dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan pendidikan, pelatihan, dan riset terapan.
3. Memberikan bukti nyata kontribusi pendidikan tinggi vokasi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan profesional.

1.3.3 *Stakeholder* / Mitra Institusi Kesehatan

1. Mendapatkan kontribusi dukungan tenaga praktik mahasiswa dalam kegiatan pelayanan radiologi sesuai dengan kompetensinya.
2. Berperan aktif dalam proses pendidikan tenaga profesional bidang radiologi dengan memberi masukan terhadap kompetensi yang dibutuhkan.
3. Menjadi bagian dari ekosistem kolaboratif antara institusi pendidikan dan dunia kerja dalam upaya peningkatan mutu layanan dan SDM kesehatan.

BAB II

DESKRIPSI ORGANISASI

2.1 Profil Universitas Airlangga

Universitas Airlangga (UNAIR) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri tertua dan terkemuka di Indonesia yang diresmikan pada 10 November 1954, dengan akar sejarah yang bermula dari pendirian Sekolah Dokter Jawa dan lembaga pendidikan kedokteran di Surabaya sejak awal abad ke-20. UNAIR menjadi pelopor pendidikan tinggi di Indonesia bagian timur, dengan nama yang diambil dari Raja Airlangga, tokoh sejarah Nusantara yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana. Sebagai institusi pendidikan yang terus berkembang, UNAIR kini berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan PP No. 30 Tahun 2014, yang memberikan otonomi dalam pengelolaan akademik dan kelembagaan.

Dalam pengembangannya, UNAIR menaungi berbagai fakultas di bidang ilmu kesehatan, sains, sosial, hingga teknologi, termasuk pendirian Fakultas Vokasi pada tahun 2014 sebagai wujud komitmen dalam mengembangkan pendidikan vokasional yang aplikatif dan sesuai kebutuhan industri. UNAIR juga memperluas jangkauan pendidikan melalui pembentukan kampus di Banyuwangi dan mendirikan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) pada tahun 2019 untuk memperkuat pilar keilmuan teknik. Dengan fokus pada integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, UNAIR terus berupaya mencetak lulusan yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing global.

2.1.1 Visi

Menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama.

2.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama.

2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

2.2 Profil Fakultas Vokasi

Cikal bakal pendidikan vokasional di Universitas Airlangga telah ada sejak tahun 1984 melalui penyelenggaraan berbagai program diploma yang saat itu masih berada di bawah pengelolaan masing-masing fakultas akademik. Program-program tersebut mencakup berbagai bidang, seperti Analis Medis, Radiologi, Fisioterapi, Teknik Kesehatan Gigi, Perpajakan, Kepariwisata, Sistem Informasi, dan lain sebagainya. Gagasan untuk mengonsolidasikan seluruh program diploma dalam satu wadah kelembagaan akhirnya terwujud dengan pendirian Sekolah Vokasi pada 27 Januari 2012, yang kemudian diresmikan menjadi Fakultas Vokasi pada 14 Mei 2014 melalui Keputusan Rektor Universitas Airlangga.

Fakultas Vokasi UNAIR hadir sebagai institusi setara dengan fakultas akademik dan profesi lainnya, dengan mandat memperkuat pendidikan vokasi berbasis keahlian terapan sesuai amanah UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 12 Tahun 2012. Seiring perkembangannya, Fakultas Vokasi tidak hanya menyelenggarakan program diploma dan sarjana terapan, tetapi juga membuka program magister terapan pertama, yaitu Magister Terapan Imejing Diagnostik. Dengan kurikulum adaptif dan kemitraan yang erat dengan dunia industri dan layanan kesehatan, Fakultas Vokasi UNAIR terus berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan teknologi serta dinamika dunia kerja.

2.2.1 Visi

Menjadi Fakultas Vokasi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional sebagai pelopor pengembangan ilmu terapan berdasarkan moral agama.

2.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi di bidang kesehatan, teknologi, sosial humaniora yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang inovatif dan mendharmabaktikan keahlian vokasi berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan vokasi dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mengembangkan kompetensi kewirausahaan pada bidang kesehatan, teknologi maupun sosial humaniora.

2.3 Profil Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan (TRP)

Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan (D-IV TRP) merupakan pengembangan dari Program Studi D-III Radiologi yang telah berdiri sejak 24 September 1984 berdasarkan SK Ditjen Dikti No. 0117/DIKTI/Kep/1984. Program D-III Radiologi awalnya berada di bawah Fakultas Non Gelar Kesehatan Universitas Airlangga, dibentuk berdasarkan SK Presiden RI No. 56 Tahun 1982 dan SK Mendikbud No. 0556/O/1983. Sejak awal, program ini telah berfokus pada pengembangan tenaga radiografer yang andal, profesional, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi serta kebutuhan layanan kesehatan.

Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi pencitraan medis dan tuntutan profesionalisme, pada tahun 2014 program ini ditingkatkan menjadi jenjang Sarjana Terapan dan bergabung dalam Fakultas Vokasi Universitas Airlangga melalui Keputusan Rektor No. 1539/UN3/2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2014. Program D-IV TRP bertujuan mencetak radiografer dengan kompetensi klinis tinggi, berwawasan teknologi, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global, dengan pendekatan kurikulum berbasis praktik dan kerja sama aktif dengan rumah sakit pendidikan serta mitra industri.

2.3.1 Visi

Menjadi program studi di bidang teknologi radiologi dan imejing medis yang mandiri, inovatif di bidang optimalisasi citra medis dan memiliki keterampilan radiografi intervensi, terkemuka di tingkat nasional dan internasional berbasis moral agama.

2.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasional berbasis teknologi terkini di bidang optimalisasi citra medis dan keterampilan radiografi intervensi yang terkemuka di tingkat nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan teknologi terapan di bidang radiografi dan imejing.
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang radiografi dan imejing kepada masyarakat sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional.

2.3.3 Profil Lulusan dan Deskripsi

Program Studi DIV TRP adalah salah satu prodi yang ada di Departemen Kesehatan Fakultas Vokasi Unair. Program studi DIV TRP Fakultas Vokasi Unair memiliki visi menjadi prodi yang mandiri dan inovatif di bidang optimalisasi citra medis dan radiografi intervensi terkemuka di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan misi prodi adalah menyelenggarakan Pendidikan vokasional berbasis teknologi terkini di bidang optimalisasi citra medis dan keterampilan radiografi intervensi, menghasilkan produk penelitian dan publikasi teknologi terapan di bidang optimalisasi citra medis dan radiologi intervensi serta menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang teknologi radiologi pencitraan. Profil lulusan prodi D-IV TRP adalah sebagai berikut :

1. Praktisi Radiografi

Menjadi radiografer yang terampil dan ahli dibidang penerapan teknologi radiologi pencitraan baik konvensional maupun canggih serta terkini secara mandiri dan profesional, inovatif di bidang

optimalisasi citra medis, dan memiliki keterampilan khusus di bidang radiografi intervensi.

2. Komunikator dan Entrepreneur

Menjadi radiografer yang dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak dan menjadi entrepreneur yang berhasil.

3. Manager

Menjadi manajer operasional dalam mengelola (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) pelayanan radiologi pencitraan.

4. Analisator

Menjadi radiografer yang dapat menganalisa permasalahan di bidang teknologi radiologi pencitraan dan menyelesaikan masalah dengan solusi alternatif dan metode yang sesuai.

5. Asisten Peneliti

Menjadi radiografer yang mampu membuat sebuah rancangan penelitian terapan di bidang teknologi radiologi pencitraan dibawah bimbingan.

2.3.4 Capaian Pembelajaran Lulusan

A. Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;a
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya, dan hukum/peraturan perundangan;
12. Bersikap etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Profesi Radiografer Indonesia; dan
13. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri jenis pemeriksaan radiologi yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
14. *Excellence With Morality*

B. Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka

menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

4. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

C. Pengetahuan

1. menguasai konsep teoritis radiasi, anatomi, fisiologi tubuh, dan patologi secara umum;
2. menguasai konsep teoritis anatomi radiologi, radiobiologi dan pencitraan medis (medical imaging theory) secara mendalam;
3. menguasai konsep teoritis instrumentasi pencitraan medis (medical imaging equipment theory) secara umum;
4. menguasai konsep umum dan prinsip kerja dari teknologi

pencitraan berikut:

- a. *X-ray radiography*;
- b. *magnetic resonance imaging*;
- c. *medical ultrasonography*;
- d. *computed tomography* (CT);
- e. *positron emission tomography* (PET);
- f. *Single-photon emission computed tomography* (SPECT);
- g. *Radioterapi*

- 5. Menguasai konsep umum, prinsip dan pengetahuan operasional lengkap dalam penggunaan, perawatan, dan pengujian instrumentasi *X-ray radiography*, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *medical ultrasonography*, dan *Computed Tomography* (CT);
- 6. Menguasai konsep umum, prinsip dan pengetahuan operasional lengkap dalam pemrosesan citra radiograf, proteksi radiasi, penggunaan alat bantu, pemilihan dan penerapan bahan kontras;
- 7. Menguasai konsep, prinsip dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatannya yang sering ditemui dalam memberikan pelayanan radiologi;
- 8. Menguasai konsep dan prinsip keselamatan, keamanan, dan kesehatan pasien dan pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support/BLS) pada situasi gawat darurat dan/atau bencana;
- 9. Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural lengkap tentang pencegahan penularan infeksi dan promosi kesehatan;
- 10. Menguasai konsep umum, prinsip dan teknik penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dan penjaminan mutu laboratorium radiologi;
- 11. Menguasai konsep umum dan prinsip manajemen informasi kesehatan berbasis teknologi informasi;
- 12. Menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan

teknologi mutakhir dalam bidang radiologi;

13. Menguasai pengetahuan faktual regulasi yang relevan di bidang radiologi, meliputi: prinsip-prinsip otonomi, malapraktik, dan etika yang terkait pelayanan radiologi;
14. Menguasai prinsip-prinsip Kode Etik Radiografer dan Standar Profesi Radiografer; dan
15. Menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya.

D. Keterampilan Khusus

1. Mampu melaksanakan dan mengevaluasi prosedur persiapan pemeriksaan radiologi yang meliputi persiapan pasien, alat bantu, ruangan pemeriksaan, dan pemindahan pasien ke dan dari ruangan layanan radiologi sesuai dengan kondisi fisik, psikologi dan usia berdasarkan perencanaan pemeriksaan yang telah tersedia dan Prosedur Operasional Baku (POB);
2. Mampu melakukan pencitraan radiografi dengan memerhatikan kondisi medis, psikologi dan usia yang menjamin keselamatan pasien dan petugas terhadap paparan radiasi berdasarkan perencanaan pemeriksaan yang telah tersedia, menggunakan instrumentasi sinar X dengan faktor eksposi, posisi tabung, posisi dan proyeksi pemeriksaan, objek yang akan diekspos, alat bantu dan bahan kontras sesuai Prosedur Operasional Baku (POB);
3. Mampu melakukan pencitraan menggunakan instrumentasi *Computed Tomography (CT) Scan* dengan memerhatikan kondisi medis, psikologi dan usia yang menjamin keselamatan pasien dan petugas terhadap paparan radiasi berdasarkan perencanaan pemeriksaan yang telah tersedia, memerhatikan faktor posisi, area yang di-scan, protokol, parameter, faktor eksposi, alat bantu dan bahan kontras

sesuai Prosedur Operasional Baku (POB);

4. Mampu melakukan pencitraan menggunakan instrumentasi *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) dengan memperhatikan kondisi medis, psikologi dan usia yang menjamin keselamatan pasien dan petugas, memperhatikan faktor posisi, area yang di-scan, sekuens, akuisisi data, parameter, alat bantu dan bahan kontras sesuai Prosedur Operasional Baku (POB);
5. Mampu melakukan pencitraan menggunakan instrumentasi *Ultrasonography* (USG) dengan memperhatikan kondisi medis, psikologi dan usia yang menjamin keselamatan pasien dan petugas, memperhatikan faktor posisi, frekuensi, dan transduser sesuai Prosedur Operasional Baku (POB);
6. Mampu melakukan pencitraan radiografi intervensi dengan memperhatikan kondisi medis, psikologi dan usia yang menjamin keselamatan pasien dan petugas terhadap paparan radiasi berdasarkan perencanaan pemeriksaan yang telah tersedia, memperhatikan faktor posisi, area yang di-scan (area scanning), faktor eksposi, akuisisi data, parameter, alat bantu dan bahan kontras sesuai Prosedur Operasional Baku (POB);
7. Mampu melakukan pencitraan radiografi Kedokteran Nuklir dengan memperhatikan kondisi medis, psikologi dan usia yang menjamin keselamatan pasien dan petugas terhadap paparan radiasi berdasarkan perencanaan pemeriksaan yang telah tersedia, memperhatikan penggunaan radiofarmaka, energi radioisotop, waktu paruh, akuisisi data, parameter, dan alat bantu pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB);
8. Mampu melakukan penyinaran radioterapi eksterna, pra bedah, dan after loading dengan memperhatikan kondisi medis, psikologi, dan usia berdasarkan perencanaan radioterapi sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB);

9. Mampu melakukan pengolahan, penyajian, dan analisis rekonstruksi citra (*image reconstruction*) dari instrumentasi *Computed Tomography* (CT), *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *Ultrasonography* (USG), Kedokteran Nuklir, dan Radiografi Intervensi sesuai dengan indikasi klinis pasien;
10. Mampu menyelesaikan masalah konseptual pada pelaksanaan pemeriksaan radiografi pencitraan (meliputi prosedur, proses, sistem pencitraan, proteksi radiasi, melalui analisis data dan penerapan prinsip radiografi pencitraan sesuai standar dan kewenangannya) dengan memerhatikan keselamatan pasien, petugas, dan lingkungan; serta memberikan masukan untuk metode pemeriksaan radiografi yang tepat berdasarkan analisis kesesuaian klinis, hasil citra, dan keselamatan pasien;
11. Mampu menerapkan sistem penjaminan mutu dan pengendalian mutu (*quality assurance and quality control*) melalui pengawasan, perawatan, dan pengujian peralatan radiologi sesuai dengan prosedur yang berlaku;
12. Mampu membangun komunikasi efektif dengan pasien, dokter, sesama radiografer, dan tenaga medis lain, serta menyampaikan informasi yang akurat mengenai teknik, persiapan pemeriksaan radiologi, dan rencana pemeriksaan radiologi yang menjadi tanggung jawabnya;
13. Mampu menerapkan teknologi mutakhir yang relevan dalam melaksanakan tugasnya sebagai radiografer, dan menerapkan sistem informasi radiologi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
14. Mampu melakukan penanganan bahan dan alat steril maupun non steril untuk pelayanan radiologi berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku dan melaksanakan program Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lingkungan kerja sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB).

15. Mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan radiologi sesuai dengan prinsip pelayanan kesehatan dan wirausaha untuk menghasilkan pelayanan radiologi yang prima.
16. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian terapan di bidang teknologi radiologi pencitraan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian.

BAB III

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan (D-IV TRP) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Kegiatan ini dirancang sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman langsung di fasilitas pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi klinis mahasiswa serta memperkuat integrasi antara teori dan praktik.

PKL dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan mulai semester 4 hingga semester 7, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Semester 4 (Radiografi Klinik 1): Mahasiswa mengenal lingkungan kerja radiologi dan mengamati prosedur radiografi konvensional tanpa kontras, termasuk alur pelayanan dan dasar teknik pemeriksaan.**
2. Semester 5 (Radiografi Klinik 2): Mahasiswa mulai aktif melakukan pemeriksaan radiografi kontras, serta modality tambahan seperti mammografi, BMD (jika tersedia), dan pengenalan CT Scan tanpa kontras.
3. Semester 6 (Radiografi Klinik 3): Mahasiswa lebih mandiri dalam prosedur radiografi kontras, mammografi, dan BMD, serta mulai berlatih kompetensi dasar CT Scan tanpa kontras, disertai penerapan komunikasi dan pelayanan pasien yang lebih menyeluruh.
4. Semester 7: Mahasiswa mengikuti rotasi PKL pada pelayanan radiologi lanjut, meliputi:
 - a. CT Klinik: Penerapan prinsip teknis dan protokol pemeriksaan CT-Scan.
 - b. MRI Klinik: Pengenalan dan pelaksanaan teknik dasar pencitraan MRI.
 - c. Radiologi Intervensi Klinik: Observasi dan partisipasi terbatas pada prosedur radiologi intervensional.
 - d. Radioterapi Klinik: Pengenalan proses kerja instalasi radioterapi dan peran radiografer dalam terapi radiasi.

3.2 Rencana Kegiatan

3.2.1 Pelaksanaan

Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) mata kuliah Radiografi Klinik 1 semester IV tahun ajaran 2025/2026 adalah mahasiswa Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama **4 (empat) minggu, yaitu pada tanggal 22 Juni hingga 22 Juli 2026**, dan dilaksanakan di instalasi radiologi rumah sakit mitra.

Pelaksanaan praktik disesuaikan dengan kebijakan dan jadwal operasional masing-masing rumah sakit, termasuk pembagian shift. **Mahasiswa diperkenankan mengikuti shift pagi, siang, maupun malam, serta melanjutkan praktik dari shift pagi ke IGD apabila mendapat izin dari pihak rumah sakit dan tetap berada di bawah pengawasan petugas radiografer.**

3.2.2 Pembimbingan

Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pembimbing praktik dari program studi dan Clinical Instructor (CI) yang ditunjuk oleh instalasi radiologi rumah sakit mitra. Kedua pembimbing ini berperan dalam membimbing, memantau, dan mengevaluasi capaian kompetensi mahasiswa selama praktik berlangsung. Pembimbingan dilakukan dalam bentuk supervisi langsung oleh dosen pembimbing ke rumah sakit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dengan CI. Dalam proses bimbingan ini, terdapat sejumlah lembar supervisi (terlampir) yang wajib diisi oleh dosen pembimbing, CI, dan mahasiswa sebagai bagian dari dokumentasi dan evaluasi pembelajaran.

3.2.3 Hak Mahasiswa

1. Berhak melaksanakan praktik radiografi di bawah bimbingan instruktur
2. Berhak melakukan teknik radiografi pada pasien dengan pendampingan
3. Berhak mengoperasikan alat radiologi dasar maupun lanjutan secara terarah

3.2.4 Kewajiban Mahasiswa

1. Menjaga nama baik Institusi Pendidikan maupun Stakeholder
2. Menjaga kerahasiaan data pasien
3. Mengikuti pembekalan praktik sebelum pelaksanaan
4. Menggunakan seragam praktik sesuai ketentuan rumah sakit
5. Melaksanakan praktik sesuai jadwal dari program studi dan rumah sakit
6. Wajib mengisi presensi dan *logbook* praktik setiap hari, ditandatangani instruktur
7. Tidak meninggalkan ruang praktik tanpa izin instruktur
8. Menjaga etika terhadap pasien, rekan, instruktur, dan staf rumah sakit
9. Hadir 100% dalam kegiatan praktik. Ketidakhadiran wajib diganti sesuai ketentuan
10. Menyampaikan surat keterangan (dokter/orangtua) jika berhalangan hadir
11. Memahami dan menjalankan prosedur standar sebelum melakukan pemeriksaan
12. Dilarang mengoperasikan alat atau melakukan pemeriksaan tanpa izin atau pengawasan
13. Bertanggung jawab atas kerusakan alat yang disebabkan kelalaian pribadi
14. Mengikuti seluruh penilaian praktik sebagai syarat kelulusan
15. Mengulang praktik jika tidak memenuhi nilai kelulusan
16. Menciptakan suasana praktik yang tertib dan profesional
17. Menyusun laporan kasus dari praktik untuk dipresentasikan dan dinilai oleh tim penguji
18. Menyerahkan laporan kasus bersamaan dengan *logbook* praktik.

3.3 Capaian Kompetensi

Capaian kompetensi mahasiswa dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tidak hanya mencakup jenis dan lingkup modalitas pemeriksaan radiologi yang dikuasai, tetapi juga mencakup jumlah minimal pelaksanaan tindakan pemeriksaan secara mandiri atau dengan supervisi, yang dibuktikan melalui

portofolio dan logbook klinik. Jumlah minimal kompetensi ini disesuaikan dengan tingkat semester dan dijelaskan secara lebih detail dalam lampiran.

Berikut ini adalah ringkasan capaian kompetensi PKL berdasarkan jenjang semester:

Semester	Jenis Kompetensi	Capaian Kompetensi
Semester 4 Radiografi Klinik 1	Wajib: Radiografi konvensional tanpa kontras	1. Ekstremitas atas dan bawah 2. Rongga dada 3. Abdomen 4. Vertebrae 5. Kepala 6. Gigi geligi
	Tambahan (observasi)	Radiografi konvensional dengan kontras
Semester 5 Radiografi Klinik 2	Wajib: Radiografi konvensional dengan kontras	1. Kepala (dacryocystography, sialografi) 2. Sistem perkemihan (IVP, sistografi, dll) 3. Sistem pencernaan (UGI, T-tube cholangiography, dll) 4. Sistem reproduksi 5. BMD
	Wajib: Radiografi konvensional tanpa kontras (penguatan kompetensi)	Pemeriksaan radiografi umum seperti pada semester 4
	Tambahan	1. Mammografi 2. CT Scan kepala tanpa kontras (observasi)
Semester 6 Radiografi Klinik 3	Wajib: Radiografi konvensional dengan kontras	Seperti semester 5
	Wajib:	Kepala, leher, thorax, abdomen, ekstremitas

Semester	Jenis Kompetensi	Capaian Kompetensi
	CT Scan tanpa kontras	
	Tambahan	1. MRI tanpa kontras (kepala, spine, abdomen, muskuloskeletal) 2. Radiografi konvensional tanpa kontras 3. Radiologi intervensi
Semester 7 CT/MRI/Intervensi Klinik	Wajib: MRI tanpa dan dengan kontras	Kepala, spine, abdomen, pelvis, muskuloskeletal, payudara, whole body, cardiac
	Wajib: CT Scan tanpa dan dengan kontras	Kepala, leher, thorax, abdomen, ekstremitas, CTA cardiac, kepala, ekstremitas
	Wajib: Radiologi intervensi	Kepala leher, thorax, abdomen, ekstremitas
	Tambahan	Radiografi konvensional dan USG

3.4 Strategi Pencapaian Kompetensi

1. Pencapaian Kompetensi Kognitif

Mahasiswa diwajibkan melakukan pembelajaran mandiri (*Self-Directed Learning*) untuk mencapai kompetensi kognitif yang diharapkan. Tujuan kompetensi kognitif meliputi:

- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melaksanakan tugas spesifik sesuai bidang keahliannya serta mengacu pada standar kompetensi kerja.
- Mampu menjelaskan tujuan dari setiap prosedur pemeriksaan radiologi dengan benar.
- Mampu menjelaskan tahapan prosedur secara sistematis dan tepat, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

2. **Pencapaian Kompetensi Afektif**

Penilaian aspek afektif dilakukan oleh fasilitator secara terintegrasi dalam setiap kegiatan, baik dalam pencapaian kompetensi kognitif maupun psikomotor. Matriks atribut soft skills yang digunakan sebagai acuan penilaian tersedia pada lampiran.

3. **Pencapaian Kompetensi Psikomotor**

Kompetensi psikomotor dicapai melalui praktik langsung pada setiap unit kompetensi yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dibuktikan melalui portofolio pembelajaran dan logbook pelaksanaan kegiatan klinik.

3.5 Evaluasi dan Penilaian

3.5.1 Penilaian Mahasiswa

Untuk mengukur kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah diperoleh mahasiswa selama pelaksanaan PKL, penilaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab fasilitator lapangan atau Instruktur Klinis (CI) di institusi/rumah sakit masing-masing. Adapun kriteria penilaian meliputi:

1. **Soft skill – 40%**

a. **Kehadiran di tempat Praktik**

Menilai tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PKL sesuai jadwal yang ditetapkan oleh institusi dan lahan praktik.

b. **Penyerahan tugas dan patuh terhadap tata tertib**

Meliputi ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas serta sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku di institusi pendidikan dan rumah sakit.

c. **Percaya diri dengan berani tampil**

Menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam menunjukkan inisiatif, keberanian untuk terlibat langsung, dan tidak ragu dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

d. **Partisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat**

Dinilai dari keaktifan mahasiswa dalam diskusi, bertanya, menjawab, dan mengemukakan ide baik secara lisan maupun tulisan selama praktik klinik berlangsung.

- e. Komunikasi dengan instruktur klinik, staf radiologi, pasien, dan keluarga pasien
Mengukur kemampuan komunikasi interpersonal yang efektif dan sopan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelayanan radiologi.

2. Unit kompetensi/keterampilan – 40% (Nilai dirata-rata dari setiap unit kompetensi yang dicapai selama PKL)

- a. Prosedur pemeriksaan
Meliputi pemahaman dan ketepatan pelaksanaan prosedur radiologi sesuai standar operasional prosedur (SOP).
- b. Persiapan peralatan dan perlengkapan
Kemampuan dalam menyiapkan alat-alat radiologi, termasuk pengaturan parameter dan pengecekan fungsionalitas.
- c. Persiapan pasien
Mencakup interaksi awal dengan pasien, edukasi singkat pada pemeriksaan tanpa persiapan maupun edukasi mendalam pada pemeriksaan dengan persiapan, serta memastikan kenyamanan dan keamanan pasien sebelum pemeriksaan.
- d. Penatalaksanaan pemeriksaan
Penilaian atas pelaksanaan prosedur pemeriksaan secara langsung, termasuk posisi pasien, teknik eksposi, dan penyesuaian protokol sesuai kebutuhan.
- e. Pemrosesan citra setelah pemeriksaan
Menilai keterampilan dalam memproses, menyimpan, serta mengevaluasi hasil citra untuk memastikan kualitas diagnostik yang baik.

3. Laporan kasus – 20%

- a. Tata penulisan dari sistematika, penggunaan bahasa, dan penulisan referensi

Kerapihan struktur laporan, penggunaan bahasa ilmiah yang sesuai, serta ketepatan dalam mencantumkan sumber referensi.

b. Isi laporan

Menilai kesesuaian antara latar belakang, rumusan masalah, pembahasan kasus, analisa, kesimpulan, dan saran berdasarkan kasus yang dipilih.

c. Kemampuan menyajikan materi, berpenampilan dan sikap, serta media penyajian

Penilaian dilakukan saat presentasi laporan, mencakup kejelasan penyampaian materi, sikap profesional, serta penggunaan media yang efektif dan menarik.

Laporan kasus dapat disajikan dalam bentuk presentasi PowerPoint, poster, atau video, namun tetap wajib menyusun naskah akademik laporan kasus secara tertulis sesuai format sebagai dokumen resmi evaluasi.

Batas minimum kelulusan adalah nilai B, dengan standar penilaian yang telah ditetapkan oleh Universitas Airlangga sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – < 86	AB	3,5
70 – < 78	B	3
62 – < 70	BC	2,5
54 – < 62	C	2
40 – < 54	D	1
< 40	E	0

3.5.2 Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Evaluasi pelaksanaan Praktik Klinik Radiografi II dilakukan secara dua arah antara institusi pendidikan dan rumah sakit mitra.

Evaluasi dari pihak Universitas Airlangga terhadap rumah sakit pelaksana dapat mengikuti format evaluasi yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit, dan diisi oleh dosen pembimbing bersama mahasiswa berdasarkan pengalaman selama kegiatan PKL berlangsung.

Sementara itu, evaluasi terhadap mahasiswa dan institusi Universitas Airlangga akan dilakukan melalui Google Form yang akan didistribusikan kepada *Clinical Instructor* (CI) dan bagian Diklat masing-masing rumah sakit. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk peningkatan mutu pelaksanaan PKL berikutnya serta penguatan kolaborasi antara institusi pendidikan dan lahan praktik.

3.5.3 Dasar Pembiayaan PKL

Pembiayaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Memorandum of Agreement (MoA) yang masih berlaku antara Universitas Airlangga dan mitra Rumah Sakit. Seluruh ketentuan terkait besaran biaya, ruang lingkup kegiatan, serta komponen pembiayaan PKL mengacu pada MoA tersebut dan menjadi dasar resmi dalam proses administrasi dan keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Universitas Airlangga menerapkan mekanisme pengelolaan keuangan yang terpusat. Oleh karena itu, diperlukan kesesuaian format dan kelengkapan dokumen penagihan dari mitra Rumah Sakit agar proses pembayaran dapat diproses sesuai dengan ketentuan institusi.

3.5.4 Mekanisme Penagihan dan Pembayaran Biaya PKL

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), sering ditemukan kendala administratif berupa ketidaksesuaian format dan mekanisme penagihan dari mitra Rumah Sakit, sehingga proses pembayaran tidak dapat diproses oleh Universitas Airlangga. Oleh karena itu, mekanisme penagihan dan pembayaran biaya PKL diatur sebagai berikut:

1. Format dan Ketentuan Invoice (Wajib)

Mitra Rumah Sakit wajib menerbitkan invoice/penagihan resmi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Invoice dapat menggunakan kop institusi Rumah Sakit atau tanpa kop
 - b. Invoice wajib mencantumkan:
 - i. Judul dokumen: Invoice / Penagihan
 - ii. Identitas pihak yang ditagih (Customer): Rektor Universitas Airlangga, Alamat: Mulyorejo, Kampus C Surabaya
 - iii. Rincian biaya pelaksanaan PKL
 - iv. Total biaya yang ditagihkan
 - v. Terbilang
 - vi. Informasi rekening tujuan pembayaran berupa nomor rekening resmi Rumah Sakit
 - vii. Invoice **wajib** ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - viii. Invoice **wajib** dibubuhi stempel resmi Rumah Sakit
2. Ketentuan Rekening Tujuan Pembayaran
- a. **Rekening tujuan pembayaran wajib berupa nomor rekening institusi Rumah Sakit**
 - b. *Virtual Account* (VA) tidak dapat digunakan sebagai tujuan pembayaran
 - c. Ketentuan ini diberlakukan untuk memenuhi aturan Direktorat Keuangan Universitas Airlangga terkait kepatuhan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - d. Invoice yang mencantumkan *Virtual Account* atau rekening non-institusi dinyatakan tidak sesuai dan wajib dilakukan revisi oleh mitra Rumah Sakit.
3. Ruang Lingkup Biaya dalam Invoice
- Universitas Airlangga menetapkan bahwa seluruh tagihan biaya PKL yang diajukan oleh Rumah Sakit diperlakukan sebagai *institutional fee*. Dengan demikian, Universitas Airlangga tidak melakukan pemisahan maupun distribusi komponen biaya secara individual, termasuk tidak melakukan pembayaran langsung

kepada Supervisor atau Clinical Instructor (CI). Invoice yang diajukan oleh Rumah Sakit harus bersifat komprehensif, mencakup seluruh komponen biaya pelaksanaan PKL (Contoh : Biaya Orientasi PKL, Biaya pembimbingan oleh Supervisor / *Clinical Instructor* (CI), Komponen lain yang secara resmi ditetapkan oleh Rumah Sakit dsb.)

Pengelolaan dan distribusi internal atas institutional fee tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Rumah Sakit, sesuai dengan kebijakan internal masing-masing institusi terhadap unit kerja dan sumber daya terkait.

Tidak diperkenankan adanya:

- a. Penagihan terpisah di luar invoice resmi yang diajukan oleh Rumah Sakit.
- b. Penagihan langsung kepada mahasiswa dalam bentuk apa pun.

Seluruh komponen biaya pelaksanaan PKL wajib tercantum dalam satu invoice resmi dan menjadi dasar tunggal proses pembayaran oleh Universitas Airlangga.

4. Mekanisme Pembayaran

- a. Pembayaran dilakukan melalui satu pintu oleh Direktorat Keuangan Universitas Airlangga
- b. Pengajuan pembayaran dilakukan oleh Program Studi melalui Fakultas
- c. Universitas tidak memproses pembayaran ke rekening pribadi, unit, atau pihak lain di luar ketentuan resmi.

BAB IV

PENUTUP

Proposal Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun sebagai bentuk perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa Program Studi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga. PKL merupakan bagian integral dari kurikulum yang bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis, meningkatkan pemahaman lapangan, serta membentuk sikap profesional mahasiswa dalam lingkungan kerja nyata.

Melalui pelaksanaan PKL, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan praktik kerja di institusi pelayanan kesehatan, serta membangun kompetensi sesuai dengan standar profesi radiografer. Proposal ini memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatan, serta rencana pelaksanaan yang terstruktur sebagai landasan awal sebelum memasuki tahap pelaksanaan.

Diharapkan proposal ini dapat menjadi acuan bersama bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak institusi mitra dalam menyelaraskan kegiatan PKL agar tercapai hasil yang optimal. Dengan persiapan yang matang, mahasiswa diharapkan mampu menjalani PKL secara bertanggung jawab, memperoleh pengalaman yang bermakna, dan berkontribusi secara positif di lahan praktik.

LAMPIRAN 1

(KOP INSTITUSI / TANPA KOP)

**INVOICE
PENAGIHAN**

Nomor : Kota,

CUSTOMER :

Nama : Rektor Universitas Airlangga Surabaya

Alamat : Mulyorejo, Kampus C Surabaya

No.	NAMA	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp)
1	<i>Uraian Biaya</i> <i>Mohon</i> <i>disebutkan PKL</i> <i>Periode waktu</i> <i>....</i>	<i>Satuan tarif x jumlah satuan</i>	<i>tarif total</i>
	TOTAL		

Terbilang :

Pembayaran di transfer kepada Rumah Sakit melalui :

Nama Bank :

Nomor Rekening :

Atas nama :

.....

.....

(nama terang/NIP dan Stempel Rumah Sakit)

Catatan :

LAMPIRAN 2 EVALUASI DAN PENILAIAN

LEMBAR PENILAIAN SOFT SKILL

(PENILAIAN DILAKUKAN SATU KALI DI MINGGU AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN)

Nama : _____

NIM : _____

No	Atribut Soft Skill	Definisi	Indikator	Skor			
				1	2	3	4
1	Disiplin	Ketepatan waktu dalam mengikuti kegiatan PKL	Kehadiran di tempat Praktik				
2		Ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan tata tertib PKL	Penyerahan tugas dan patuh terhadap tata tertib				
3	Percaya Diri	Keberanian dan kepercayaan peserta didik dalam melakukan prosedur pemeriksaan	Berani tampil				
4	Partisipasi Aktif	Keikutsertaan secara aktif dalam setiap kegiatan PKL	Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan melalui bertanya, memberikan jawaban penyampaian ide				
5	Sikap	Komunikasi dengan sejawat	Komunikasi dengan instruktur klinis				
6			Komunikasi dengan staf radiologi				
7		Komunikasi dengan pasien	Komunikasi dengan pasien				
8			Komunikasi dengan keluarga pasien				
Jumlah							

Kriteria Penilaian

1. KURANG : Selalu memerlukan bimbingan
2. CUKUP : Sesekali memerlukan bimbingan, namun belum mampu mandiri.
3. BAIK : Mampu secara mandiri, namun harus didampingi instruktur klinis.
4. SANGAT BAIK : Mampu secara mandiri tanpa didampingi instruktur klinis

Total Nilai Soft Skill

Nilai = (Jumlah / 32) x 100 =

_____, ____/____/2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Penilai,
Instruktur Klinis

LEMBAR PENILAIAN KOMPETENSI
(PENILAIAN DILAKUKAN DI SETIAP UNIT KOMPETENSI)

Nama : _____

NIM : _____

Unit Kompetensi : Radiografi Konvensional Tanpa Kontras

Nama Pemeriksa : _____

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI			
		1	2	3	4
Prosedur Pemeriksaan					
1	Identifikasi data pasien				
2	Identifikasi klinis pemeriksaan				
Persiapan Peralatan dan Perlengkapan					
3	Persiapan pesawat sinar-X dan kaset perekam				
4	Persiapan alat pemroses citra (CR/DR)				
5	Persiapan alat proteksi radiasi				
6	Persiapan alat bantu dan penunjang				
7	Persiapan media kontras dan alat penyuntikan				
Persiapan pasien					
8	Pemanggilan pasien sesuai data registrasi				
9	Pasien diidentifikasi/dilakukan anamnesa				
10	Pasien diberikan edukasi terkait pemeriksaan				
11	Konfirmasi kehamilan khusus pasien wanita				
12	Identifikasi riwayat alergi				
Penatalaksanaan pemeriksaan					
13	Pengaturan posisi pasien dan objek pemeriksaan				
14	Penempatan marker sesuai objek yang diperiksa				
15	Penggunaan alat proteksi radiasi				
16	Pengaturan proyeksi tabung				
17	Pengaturan parameter eksposi				
18	Instruksi saat eksposi sesuai dengan pemeriksaan				
Setelah Pemeriksaan (Processing Citra)					
19	Pengolahan data citra				
20	Identifikasi kesesuaian hasil dengan jenis pemeriksaan				
21	Evaluasi kualitas citra				
22	Dokumentasi hasil (pencetakan/filming)				
Jumlah					

Kriteria Penilaian

1. **KURANG** : Tidak mampu
2. **CUKUP** : Mampu namun harus diarahkan oleh instruktur/pembimbing
3. **BAIK** : Mampu dengan baik
4. **SANGAT BAIK** : Mampu secara mandiri dengan sangat baik

K adalah Kompeten
Nilai ≥ 65 ekuivalen B (Baik)
BK adalah Belum Kompeten
nilai < 65

Total Nilai Unit Kompetensi

Nilai = (Jumlah / 88) x 100 =	K	BK

_____, ____/____/2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Penilai,
Instruktur Klinis

REKAPITULASI NILAI UNIT KOMPETENSI
(REKAP DILAKUKAN SETELAH MENGAMBIL PENILAIAN UNIT KOMPETENSI)

Nama : _____
NIM : _____
Mata Kuliah : _____
Tempat Praktik : _____

No	Unit Kompetensi / Pemeriksaan	NILAI
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Nilai Total		
Rata-Rata		

_____, ____/____/2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Penilai,
Instruktur Klinis

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN KASUS

(PENILAIAN DILAKUKAN SATU KALI DI MINGGU AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN)

Nama : _____
NIM : _____
Judul Laporan Kasus : _____
Tempat Praktik : _____

No	Aspek yang dinilai	Bobot Nilai	Nilai
Tata Penulisan		30%	
1	Sistematika penulisan	10	
2	Penggunaan bahasa	10	
3	Penulisan Referensi	10	
Isi Laporan		40%	
4	Kesesuaian latar belakang dengan rumusan masalah	10	
5	Kesesuaian analisa permasalahan	10	
6	Pembahasan	10	
7	Kesimpulan dan saran	10	
Penyajian		30%	
8	Kemampuan dalam penyajian materi	10	
9	Penampilan dan sikap	10	
10	Media penyajian	10	
Total Nilai		100% (100)	

_____, ____/____/2025

**Mengetahui,
Dosen Pembimbing**

**Penilai,
Instruktur Klinis**

BERITA ACARA

Berdasarkan keputusan rapat dosen pembimbing dan instruktur klinis pada hari _____ tanggal ____ bulan _____ tahun 20____ di Bagian / Instalasi

Radiologi Rumah Sakit _____, ditetapkan bahwa :

Nama : _____

NIM : _____

Dinyatakan,

LULUS / TIDAK LULUS *

Praktik klinik mata kuliah _____ dengan nilai :

No	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1	Soft Skill	40% x _____	
2	Keterampilan	40% x _____	
3	Laporan Kasus	20% x _____	
Total Nilai			

_____, ____ / ____ /2025

**Mengetahui,
Dosen Pembimbing**

**Penilai,
Instruktur Klinis**
